# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67755
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2023-07-20 12:23:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | : MANUEL JESUS FUENTES CHAVEZ | | | **RUN** | : 5.798.527-5 |
| **F.Nac** | : 26-12-1946 | **Edad** | : 76 AÑOS, 6 MESES | **Género** | : Masculino |
| **Dirección** | : EL SAUCE | | | **Comuna** | : CHILLAN |
| **Previsión** | : FONASA B | **Teléfono** | : 91224081 | | |
| **Fecha Ingreso** | : 2023-07-12 | **Fecha Egreso** | : 2023-07-20 12:23:00 | **Causal** | : MEDICA |
| **Condición** | : VIVO | **Destino** | : HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA | **Derivación** | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.1-HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO, CORTICAL

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-Hemorragia temporal derecha, etiología en estudio
-Neumonía, probablemente aspirativa en tto.
-Deficit B12
-Deterioro cognitivo previo
-Fibrilación auricular, cardiovertida eléctricamente

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I62.9-HEMORRAGIA INTRACRANEAL (NO TRAUMATICA ), NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente sin antecedentes mórbidos conocidos, es trasladado vía SAMU al SU del HSC el día 11/07/2023 por cuadro de agitación psicomotora, dificultad a la marcha y dificultad para hablar. Ingresa febril, agitado, agresivo y afásico, destaca Glasgow 11 puntos, con isocoria, no obedece ordenes, no emite palabra, sin déficit motor ni sensitivo, bainski dudoso izquierdo. Se realiza toma de HC (2) y exámenes, además, se inicia tratamiento ATB empírico, destacando antecedente de neumonía recurrente. Exámenes realizados destaca crea 0.7, lactato 1.8, 10.700 blancos e hiponatremia de 131. Se realiza tc cerebro que evidencia Lesión hemorrágica con hematoma intraparenquimatoso agudo subcortical temporal derecho de bordes irregulares, con moderado edema vasogénico y efecto de masa sobre los surcos de la convexidad adyacentes. Infartos lacunares antiguos en cuerpo estriado derecho y tálamo izquierdo. Se traslada a HCHM para evaluación por neurocirujano quien descarta manejo quirúrgico indicando manejo médico. Retorna a HSC en malas condiciones generales, mantiene febril y agitado con disartria. Destaca signología productiva bronquial y dado parámetros de inflamación junto con antecedentes, se realiza tc torax que evidencia foco de condensación basal derecho y atelectasias mayora derecha. Es evaluado por NRL donde se indica TC de control que no muestra cambios e indica manejo en UTI por lo que se ingresa. Destaca que en urgencia se instala sonda Foley con trauma secundario por lo que mantiene hematuria macroscópica. Se decide ingreso a UTI para manejo hemodinámico y monitorización.
Evolución en UTI:
- Hemodinamia: requiere manejo antihipertensivo con BIC de Urapidil, ajuste farmacológico oral multiasociado, logrando normotensión hace más de 48 hrs. Presentó FA cRVR el 18/07, la cual se manejó con CVE y se carga con amiodarona. Se mantiene sin anticoagulación por contraindicación actual, se definirá posterior inicio según evolución neurológica en forma ambulatoria. Pendiente ecocardiograma, que se puede realizar en forma ambulatoria.
- Ventilatorio: se apoya con FiO2 suplementaria hasta 24-28%, broncodilatación y KNT respiratoria en contexto de neumonía. Buena evolución, actualmente si requerimientos de FiO2 suplementaria.
- Infeccioso: ingresa con cuadro infeccioso de foco pulmonar imageneológicamente compatible con

neumonía de presunto origen aspirativo, iniciándose tratamiento empírico antibiótico. Influenza y covid negativo. Actualmente en 7° día, con buena respuesta clínica y de laboratorio. HC hasta ahora negativos (pendientes).
- Renal: Actualmente sin conflicto
- Neurológico: bajo seguimiento por especialidad, manteniendo metas de presión arterial, reposición de B12, en rehabilitación kinésica bien tolerada. TC cerebro s/c de control del día 19/07, con HIC en regresion, mismo efecto de masa. Neurológicamente en su basal, incluyendo disartria, según relato de familiar (hermana). Bajo rehabilitación Fonoaudiológica, puede recibir régimen oral. Al examen mental se encuentra vigil, OTE, no invierte series pero impresiona adecuadamente atingente al medio, lenguaje N, distingue derecha-izquierda cruzando línea media. -PC: CV impresiona conservado, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, motilidad y sensibilidad faciales impresionan N, disartria leve e intermitente, nistagmo(-), pares bajos impresionan Normal. -Motor: BC impresiona M4-5 en las 4 EE, RCP impresiona flexor bilateral.

## PLAN DE MANEJO:

- Hemodinámico: Ajuste terapia antihipertensiva, mantener amiodarona, en caso de PAS>150 mmHg agregar amlodipino 5 mg al dia. No AAS ni anticoagular. Ecocardio ambulatorio (se envia orden). Definir inicio de anticoagulación cuando condiciones neurológicas lo permitan determinado por neurólogo. Mantener controles por PSCV en CESFAM al alta.
- Respiratorio: mantener KNT resp
- Infeccioso: completó tto atb, con buena respuesta
- Neurológico: rehabilitacion kinésica motora. Control ambulatorio por neurologia en 15 dias. Antecedente de deterioro cognitivo previo. Mantener risperidona.
- Traslado a HODOM para continuar rehabilitación kinésica

## INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Régimen papilla
3. Omeprazol 20mg por dia vo
4. Acido Valproico 200mg vo cada 8 hrs
5. Enalapril 10 mg 1 comprimido c/12 horas
6. Furosemida 40 mg ½ comprimido vo
7. Amiodarona 200 mg 1 comprimido c/12 h vo (2/5 días), luego mantener 1 comprimido al día Risperidona 1 mg c/12 horas vo
8. Risperidona 1 mg c/12 horas vo
9. HODOM para Rehabilitación kinésica motora
10. Ecocardiograma doppler ambulatorio
11. Control neurologia CAE en 15 días

## EXÁMENES Y RESULTADOS

18/07/23: crea 0.8 BUN 11 ELP 138/3.6/100 GB 11100 Hb 12.8 Plt 311 mil
14/7/23: -Glic 98 -Hb glic 5.4 -Crea 0.7 MDRD 109.65 Uremia 53 -AU 5.9 -Ca 8.3 Na 134 K 3.9 Cl 102 -FA 110 BI 0.37 BD 0.23 BT 0.6 GOT 46 GPT 22 GGT 15 -INR 1.16
-ColT 214 HDL 28 LDL 163 VLDL 22.8 TG 114 -Leu 9300 Hb 12.6 Plaq 187000 Seg 77 VHS 20
-TSH 3.391 T4L 1.08
-B12 123 Folato 17.1

TC cerebro 11/07/23: Lesión hemorrágica con hematoma intraparenquimatoso agudo subcortical temporal derecho de bordes irregulares, con moderado edema vasogénico y efecto de masa sobre los surcos de la convexidad adyacentes. Infartos lacunares antiguos en cuerpo estriado derecho y tálamo izquierdo
TC cerebro 19/07/23: HIC en regresion, mismo efecto de masa

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Ana Sepúlveda Venegas
MEDICO TRATANTE

JEFE SERVICIO

13383078-2